RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO · RIPOSTE À LA MALADIE À VIRUS EBOLA

# Rapport épidémiologique national

Maladie à virus Ebola · situation au 19 oct. 2026

Période de rapportage
**13 oct. – 19 oct. 2026**
Semaine épidémiologique S43 · 2026
SitRep de référence : N° 148

Sources : SitRep SitRep_MVEBDB_148_09_10_2026.pdf · Linelist LINELIST_19102026.xlsx · lln lln_mve_notifications_2026-05-01_latest.csv · contact tracing SUIVI_CONTACTS_19102026.xlsx. Données extraites le 19 oct. 2026. Rapport généré automatiquement — à valider par l'équipe de surveillance avant diffusion.

## 1. POINTS SAILLANTS

**Tableau 1 : Cumul national depuis le début de l'épidémie (SitRep N° 148, publié le 10 oct. 2026)**

| Cas confirmés | Décès | Létalité | Guéris | En isolement / CTE | Suivi des contacts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 914 | 4 315 | 48,4 % | 2 338 | 946 | 83,1 % |

Nouveaux cas des dernières 24 h : 69 ; nouveaux décès : 40. Létalité = décès / cas confirmés.

**Tableau 2 : Période de rapportage du 13 oct. au 19 oct. 2026 (Linelist, date de notification)**

| Cas confirmés (7 j) | 7 j précédents | Variation | Décès (7 j) | Létalité (7 j) | Alertes (7 j) |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 458 | -21 % | 137 | 37,7 % | 5 669 |

**Tableau 3 : Zones de santé selon la situation épidémiologique**

| Situation de la zone de santé | Définition | Zones | % |
|---|---|---|---|
| Rouge | Cas < 21 j et ≥ 1 critère d'aggravation (ou ≥ 2 critères de contexte) | 40 | 18 % |
| Orange | Cas < 21 j, sans critère rouge | 12 | 6 % |
| Jaune | Dernier cas il y a 22 à 42 jours | 7 | 3 % |
| Verte | Plus de 42 jours sans cas | 12 | 6 % |
| Non touchée | Aucun cas | 146 | 67 % |

### Messages clés

- Du 13 oct. au 19 oct. 2026, **363 cas confirmés** et 137 décès ont été notifiés (létalité 37,7 %), contre 458 cas la semaine précédente : tendance **en baisse** (-21 %).
- Cumul officiel (SitRep N° 148 du 9 oct. 2026) : **8 914 cas confirmés**, 4 315 décès (létalité 48,4 %), 2 338 guéris et 946 patients en isolement/CTE.
- Le nombre de reproduction effectif consolidé est de **0,93** (IC 95 % 0,85–1,02) au 6 oct. 2026 ; probabilité que Rt > 1 : 7 %.
- 71 zones de santé ont été touchées : **40 en rouge** (hotspots), 12 en orange, 7 en jaune et 12 en vert (> 42 jours sans cas).
- 2 zones en priorité 1 (score ≥ 70) et 16 en priorité 2 (50–69) ; zones les plus prioritaires : Lubero (81), Beni (76), Mabalako (69), Mandima (68), Mambasa (68).
- Suivi des contacts : 1 623 contacts en suivi, **35,3 % vus** le 19 oct. 2026, 871 non vus depuis plus de 3 jours ; seuls **0,9 %** des nouveaux cas étaient connus comme contacts.

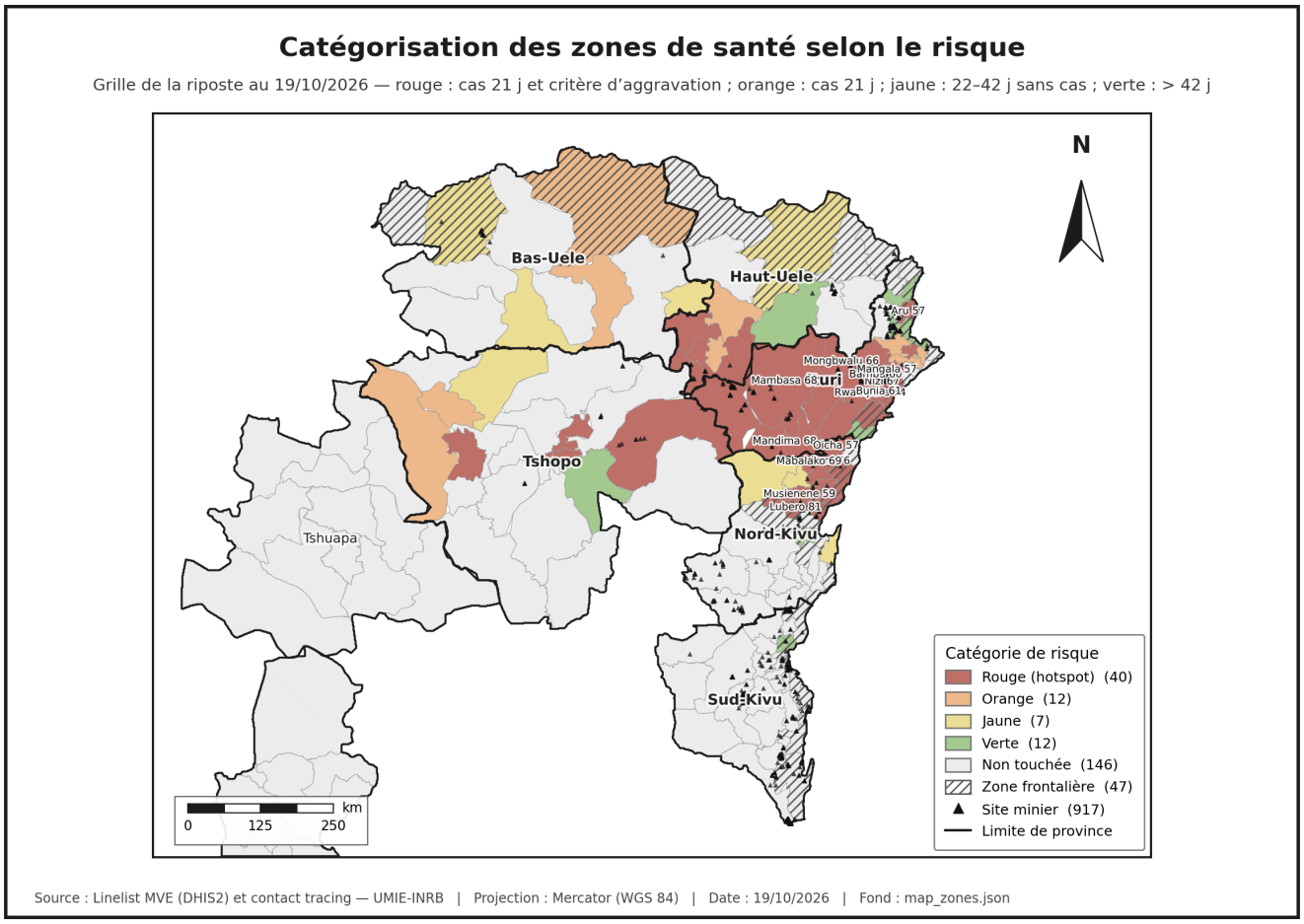



**Figure 1** : situation épidémiologique des zones de santé au 19 oct. 2026 (catégories de risque).

## 2. CONTEXTE

L'épidémie de maladie à virus Ebola est en cours depuis le 3 mai 2026 (premier cas confirmé notifié dans la Linelist). Au 19 oct. 2026, 7 provinces ont notifié des cas : Ituri (6 609 cas, 28 zones touchées sur 36), Nord-Kivu (1 858 cas, 17 zones touchées sur 34), Haut-Uélé (372 cas, 7 zones touchées sur 13), Tshopo (57 cas, 7 zones touchées sur 23), Bas-Uélé (13 cas, 4 zones touchées sur 11), Sud-Kivu (3 cas, 1 zones touchées sur 34), Sud-Ubangi (2 cas, 1 zones touchées sur 16). Ce rapport combine les chiffres officiels du SitRep (cumuls), la Linelist des cas (analyse temps–lieu–personne), le Linelist des alertes (lln) et la base de suivi des contacts (transmission et riposte).

## 3. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET DE LABORATOIRE

### 3.1 Distribution dans le temps

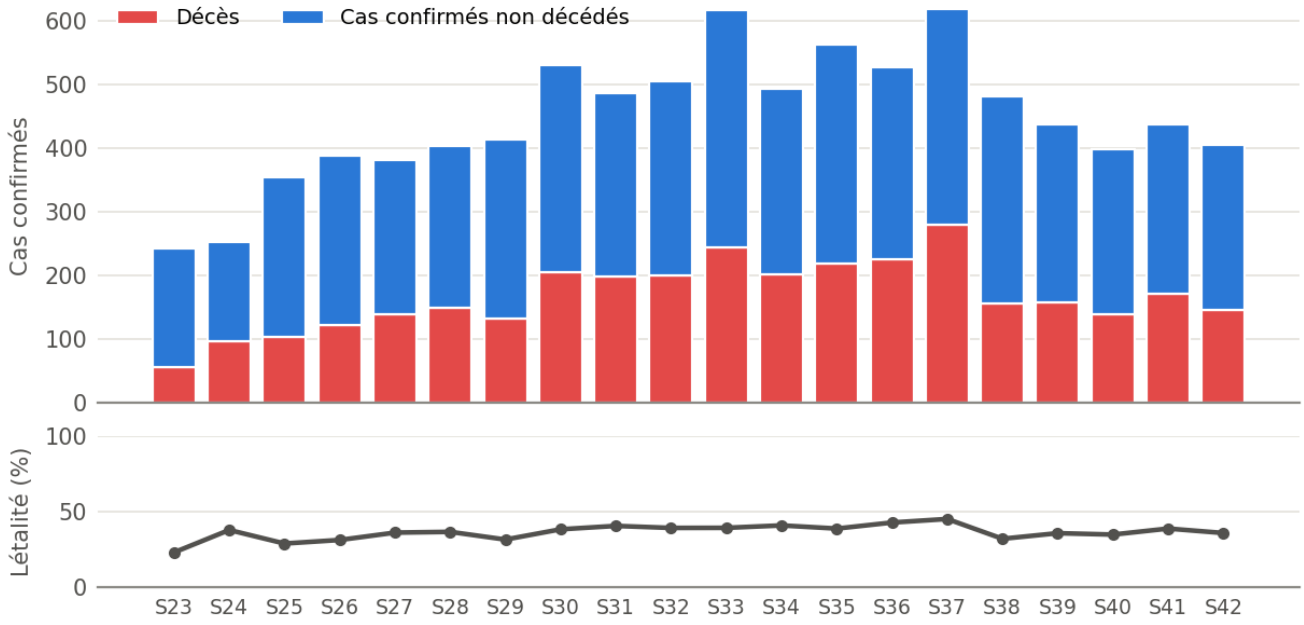



**Figure 2** : courbe épidémique hebdomadaire des cas confirmés selon l'issue (semaine de notification, n = 8 941 sur 20 semaines ; semaine en cours exclue car incomplète) et létalité hebdomadaire (panneau inférieur).

Au cours de la dernière semaine complète (S42, du 12 oct. au 18 oct. 2026), 406 cas confirmés et 146 décès ont été notifiés (létalité 36,0 %). Le pic hebdomadaire de la période représentée a été atteint en S37 (619 cas).

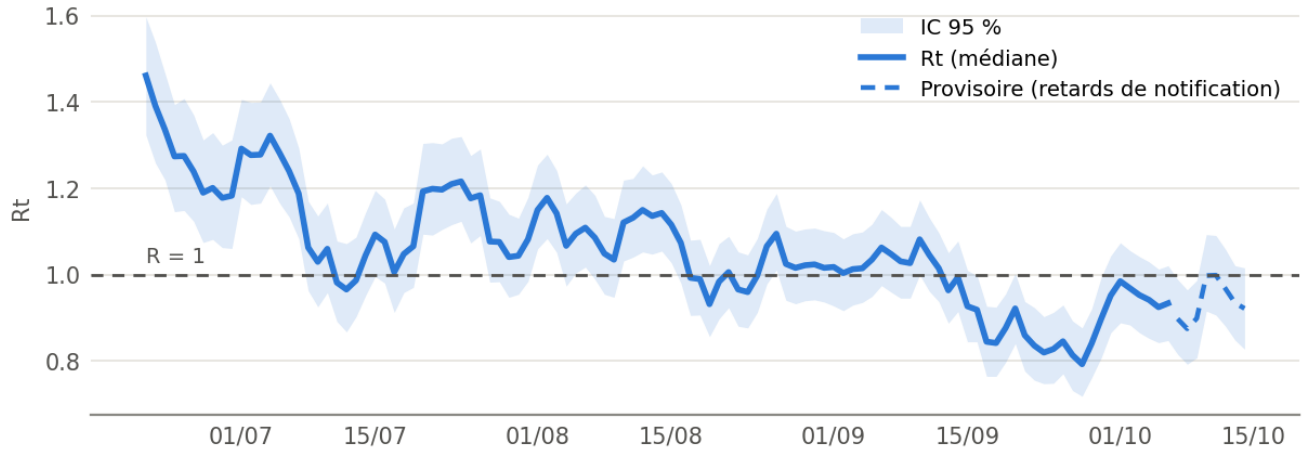



**Figure 3** : nombre de reproduction effectif national (EpiEstim, fenêtre de 7 jours, intervalle sériel estimé sur les chaînes de transmission) sur les 120 derniers jours ; trait plein = estimation consolidée, pointillé = provisoire.

Le nombre de reproduction consolidé est de **0,93** (IC 95 % 0,85–1,02) au 6 oct. 2026. Le délai médian entre le début des symptômes et la notification est de 5 jours (90e centile 13 jours) : les cas des 2 dernières semaines sont encore incomplets, ce que corrige le nowcasting (probabilité de croissance : 0,6 %).

## 3.2 Confirmation au laboratoire

**Tableau 4 : Tests de confirmation (RT-PCR) par laboratoire, cumul**

| Laboratoire | Tests valides | Positifs | Négatifs | Positivité (IC 95 %) |
|---|---|---|---|---|
| LPSP BUNIA | 6 820 | 2 703 | 4 117 | 39,6 % (38,5–40,8) |
| INRB - Antenne Beni | 2 834 | 1 123 | 1 711 | 39,6 % (37,8–41,4) |
| Labo Nizi | 2 302 | 1 086 | 1 216 | 47,2 % (45,1–49,2) |
| Autres | 2 124 | 921 | 1 203 | 43,4 % (41,3–45,5) |
| Labo Mongbwalu | 1 626 | 681 | 945 | 41,9 % (39,5–44,3) |
| Labo Nyankunde | 1 293 | 112 | 1 181 | 8,7 % (7,2–10,3) |
| Labo Komanda | 1 091 | 260 | 831 | 23,8 % (21,4–26,4) |
| INRB - Antenne Butembo | 847 | 800 | 47 | 94,5 % (92,7–95,8) |
| Autres (14 laboratoires) | 5 171 | 1 627 | 3 544 | 31,5 % |
| **Total** | **24 108** | **9 313** | **14 795** | **38,6 %** |

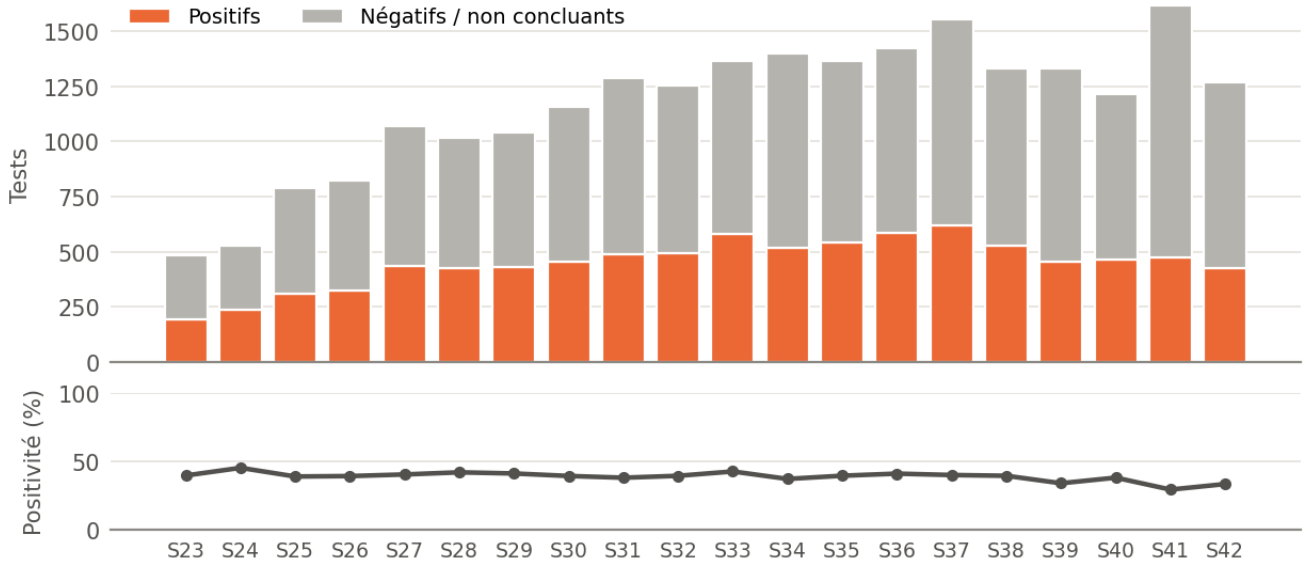



**Figure 4** : tests réalisés par semaine selon le résultat (n = 23 321) et taux de positivité hebdomadaire (panneau inférieur).

En S42, 1 268 tests ont été réalisés, dont 424 positifs (positivité 33,4 %). Délai médian prélèvement → résultat : 0 jour(s).

## 3.3 Distribution géographique

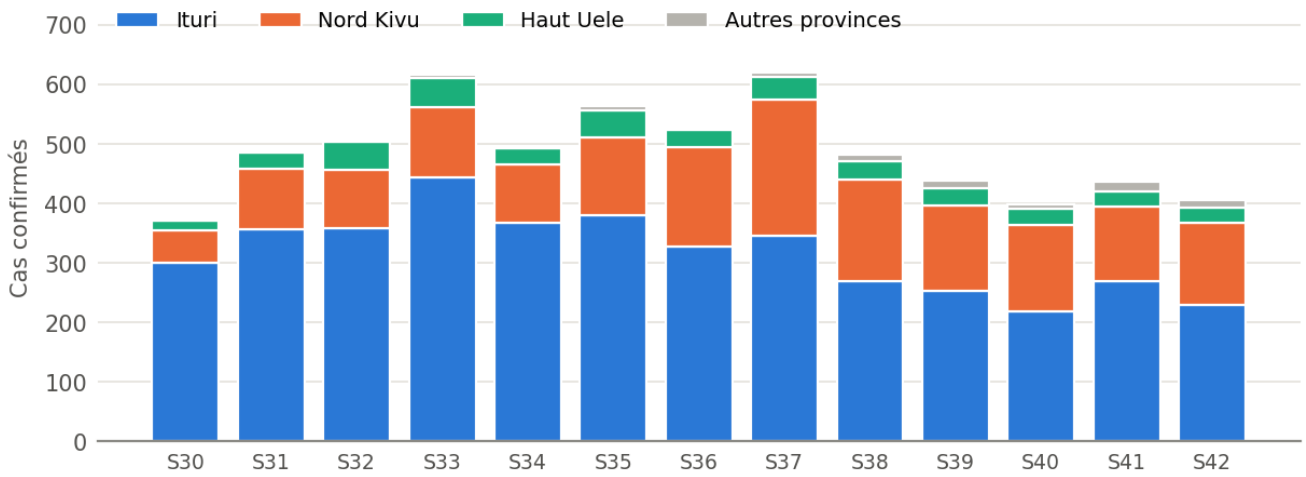



**Figure 5** : cas confirmés par semaine de notification et par province (n = 6 347).

**Tableau 5 : Cas confirmés, décès et suivi des contacts par province (Linelist ; zones et suivi : SitRep)**

| Province | Confirmés (cumul) | Décès conf. | Létalité | Confirmés 14 j | Zones touchées / total | Contacts actifs | Suivi contacts (SitRep) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituri | 6 769 | 2 463 | 36,4 % | 485 | 28 / 36 | 748 | 80,2 % |
| Nord Kivu | 2 018 | 888 | 44,0 % | 255 | 17 / 34 | 184 | 84,1 % |
| Haut Uele | 424 | 68 | 16,0 % | 48 | 7 / 13 | 255 | 90,5 % |
| Tshopo | 81 | 7 | 8,6 % | 26 | 7 / 23 | 436 | 91,0 % |
| Bas Uele | 14 | 1 | 7,1 % | 3 | 4 / 11 | 0 | 84,8 % |
| Sud Kivu | 3 | 1 | 33,3 % | 0 | 1 / 34 | 0 | — |
| Sud Ubangi | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | 1 / 16 | 0 | — |
| Nord Ubangi | 2 | 0 | 0,0 % | 2 | — | 0 | — |
| Equateur | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Kinshasa | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Kasai | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Tshuapa | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| **Total** | **9 313** | **3 428** | **36,8 %** | **821** | | **1 623** | **83,1 %** |

Les cumuls de la Linelist peuvent différer légèrement du SitRep (délais de saisie, reclassements) ; voir la section 5.

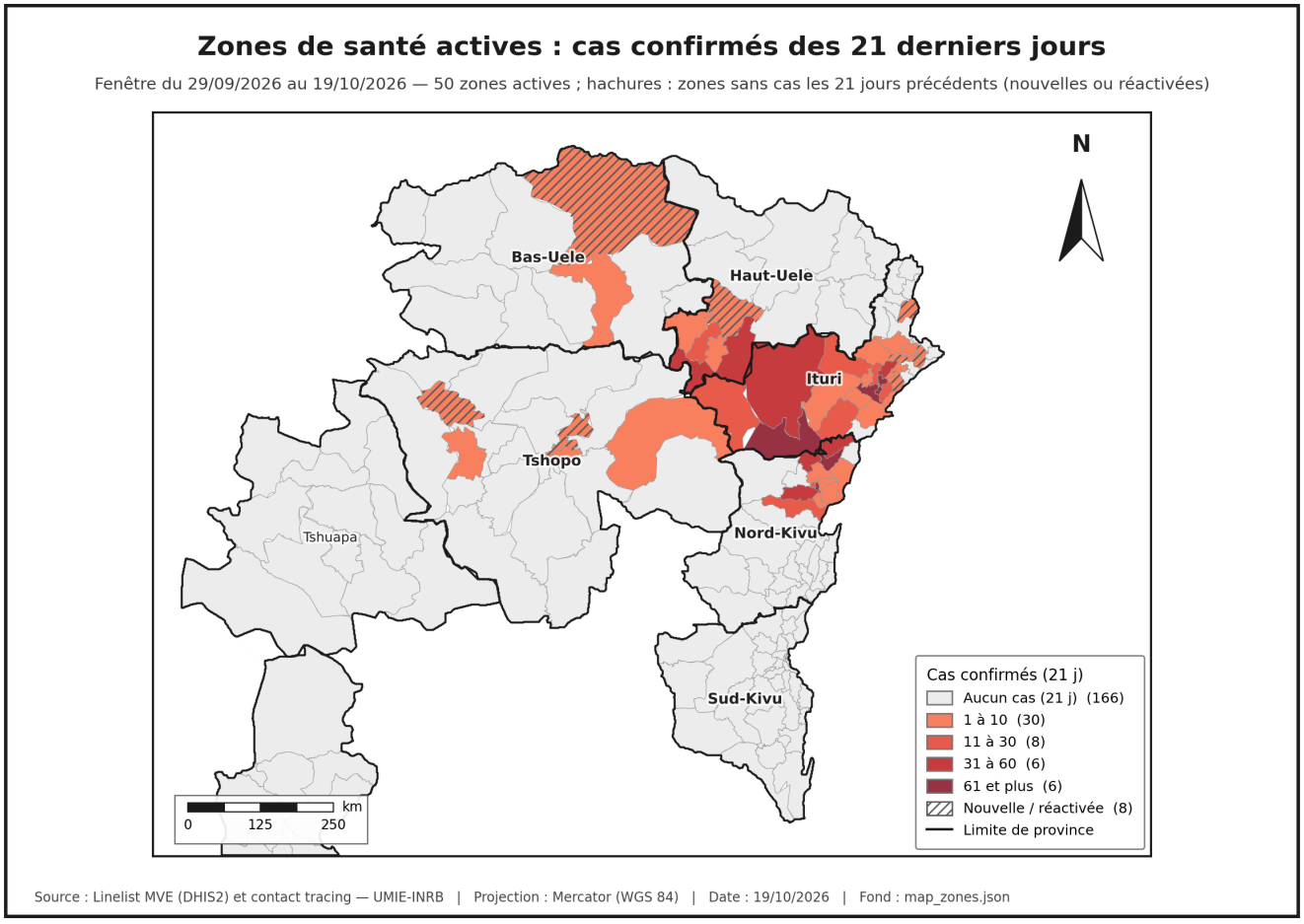



**Figure 6** : zones de santé actives : cas confirmés des 21 derniers jours.

**Tableau 6 : Les 15 zones de santé ayant notifié le plus de cas confirmés au cours des 14 derniers jours**

| Zone de santé | Province | Confirmés 14 j | 14 j précédents | Variation | Décès 14 j | Létalité | Rt | Jours depuis le dernier cas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandima | Ituri | 133 | 43 | +209 % | 63 | 47 % | 1,96 | 0 |
| Bunia | Ituri | 96 | 91 | +5 % | 43 | 45 % | 0,86 | 0 |
| Beni | Nord Kivu | 95 | 116 | -18 % | 54 | 57 % | 0,96 | 1 |
| Nizi | Ituri | 58 | 52 | +12 % | 23 | 40 % | 1,35 | 2 |
| Rwampara | Ituri | 58 | 83 | -30 % | 10 | 17 % | 0,64 | 0 |
| Katwa | Nord Kivu | 48 | 62 | -23 % | 16 | 33 % | 0,85 | 0 |
| Mabalako | Nord Kivu | 37 | 12 | +208 % | 9 | 24 % | 1,10 | 0 |
| Wamba | Haut Uele | 25 | 21 | +19 % | 5 | 20 % | 0,57 | 0 |
| Mambasa | Ituri | 25 | 13 | +92 % | 15 | 60 % | 1,37 | 1 |
| Oicha | Nord Kivu | 25 | 22 | +14 % | 5 | 20 % | 1,51 | 2 |
| Mangala | Ituri | 25 | 36 | -31 % | 10 | 40 % | 0,74 | 3 |
| Musienene | Nord Kivu | 24 | 11 | +118 % | 1 | 4 % | 1,42 | 3 |
| Lita | Ituri | 19 | 15 | +27 % | 8 | 42 % | 1,09 | 0 |
| Bambu | Ituri | 16 | 12 | +33 % | 12 | 75 % | 0,73 | 4 |
| Pawa | Haut Uele | 14 | 26 | -46 % | 4 | 29 % | 1,12 | 0 |

## 3.4 Caractéristiques des cas (âge et sexe)

**Tableau 7 : Cas confirmés et probables par groupe d'âge et sexe, décès et létalité (Linelist)**

| Groupe d'âge (ans) | Masculin | Féminin | Total | % | Décès | Létalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–4 | 693 | 602 | 1 296 | 14,0 % | 845 | 65,2 % |
| 5–14 | 472 | 490 | 962 | 10,4 % | 346 | 36,0 % |
| 15–24 | 603 | 1 050 | 1 653 | 17,9 % | 494 | 29,9 % |
| 25–34 | 912 | 1 011 | 1 923 | 20,8 % | 570 | 29,6 % |
| 35–44 | 724 | 780 | 1 504 | 16,3 % | 429 | 28,5 % |
| 45–59 | 625 | 607 | 1 232 | 13,3 % | 377 | 30,6 % |
| ≥ 60 | 300 | 378 | 678 | 7,3 % | 311 | 45,9 % |
| Âge inconnu | 52 | 60 | 112 | — | 68 | — |
| **Total** | **4 381** | **4 978** | **9 360** | 100 % | **3 440** | **36,8 %** |

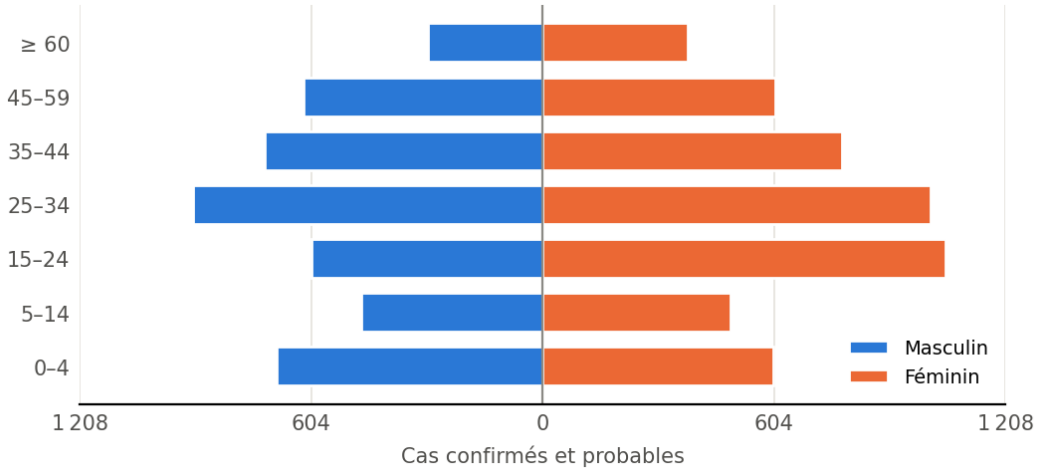



**Figure 7** : pyramide des âges des cas confirmés et probables selon le sexe.

Les femmes représentent 53,2 % des cas. Les enfants de moins de 18 ans représentent 26,3 % des cas. 161 agents de santé (personnel de première ligne) ont été confirmés depuis le début de l'épidémie.

## 3.5 Transmission et suivi des contacts

**Tableau 8 : Indicateurs de suivi des contacts et de transmission**

| Indicateur | Valeur | Commentaire |
|---|---|---|
| Contacts en cours de suivi | 1 623 | Journée de référence : 19 oct. 2026 |
| Contacts vus (dernière journée) | 35,3 % | Cible ≥ 90 % |
| Contacts non vus depuis > 3 jours | 871 | À rechercher en priorité (perdus de vue) |
| Suivi de 21 jours mené à terme | 61,9 % | Parmi les contacts sortis du suivi |
| Nouveaux cas connus comme contacts | 0,9 % | 14 derniers jours ; cible ≥ 80 % |
| Nouveaux cas avec source identifiée | 5,8 % | Liste de contacts ou investigation |
| Contacts listés par cas index (médiane) | 9 | 1 353 cas index |
| Taux d'attaque secondaire | 1,42 % | Contacts devenus cas / contacts listés |
| Chaînes de transmission reconstituées | 364 | 41 actives sur 21 jours ; 4 générations au maximum |
| Intervalle sériel | 13,6 j | Médiane 11,0 j (n = 548 paires) |

La transmission est très hétérogène (paramètre de dispersion k = 0,32) : une minorité de cas génère la majorité des cas secondaires, ce qui justifie la recherche rétrograde de la source (traçage « en amont ») et le contrôle des événements de super-propagation (funérailles, soins).

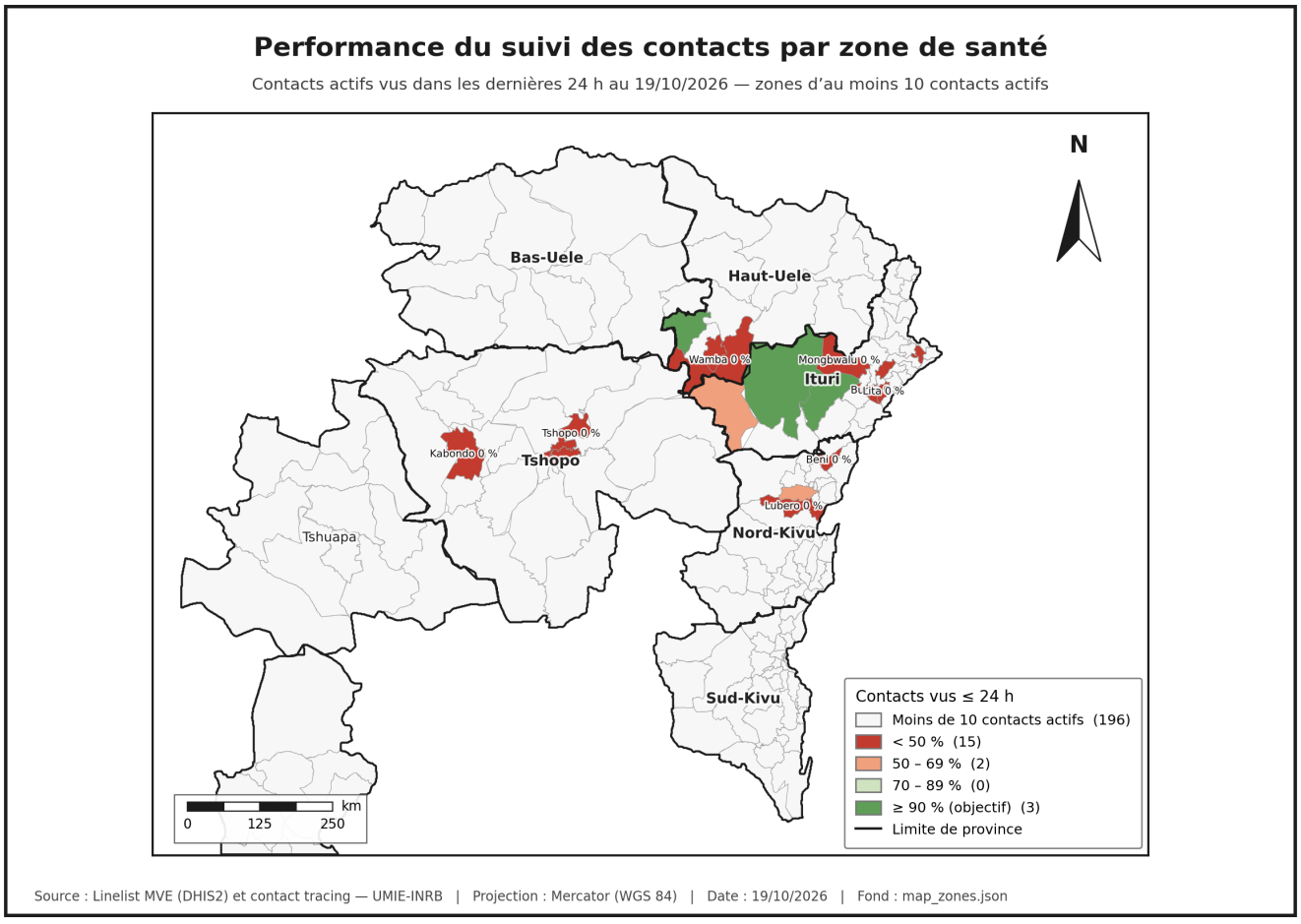



**Figure 8** : suivi des contacts par zone de santé.

## 3.6 Zones à risque et priorités opérationnelles

Chaque zone touchée reçoit un score de risque de 0 à 100 combinant la dynamique (cas des 21 derniers jours, tendance, probabilité que Rt > 1), la gravité (décès communautaires positifs, décès groupés), le contexte (proximité d'une zone à forte incidence, frontière, sites miniers) et la performance de la riposte (contacts non vus, résurgence, EDS non réalisés). Priorité 1 : score ≥ 70 ; priorité 2 : 50–69 ; priorité 3 : 30–49.

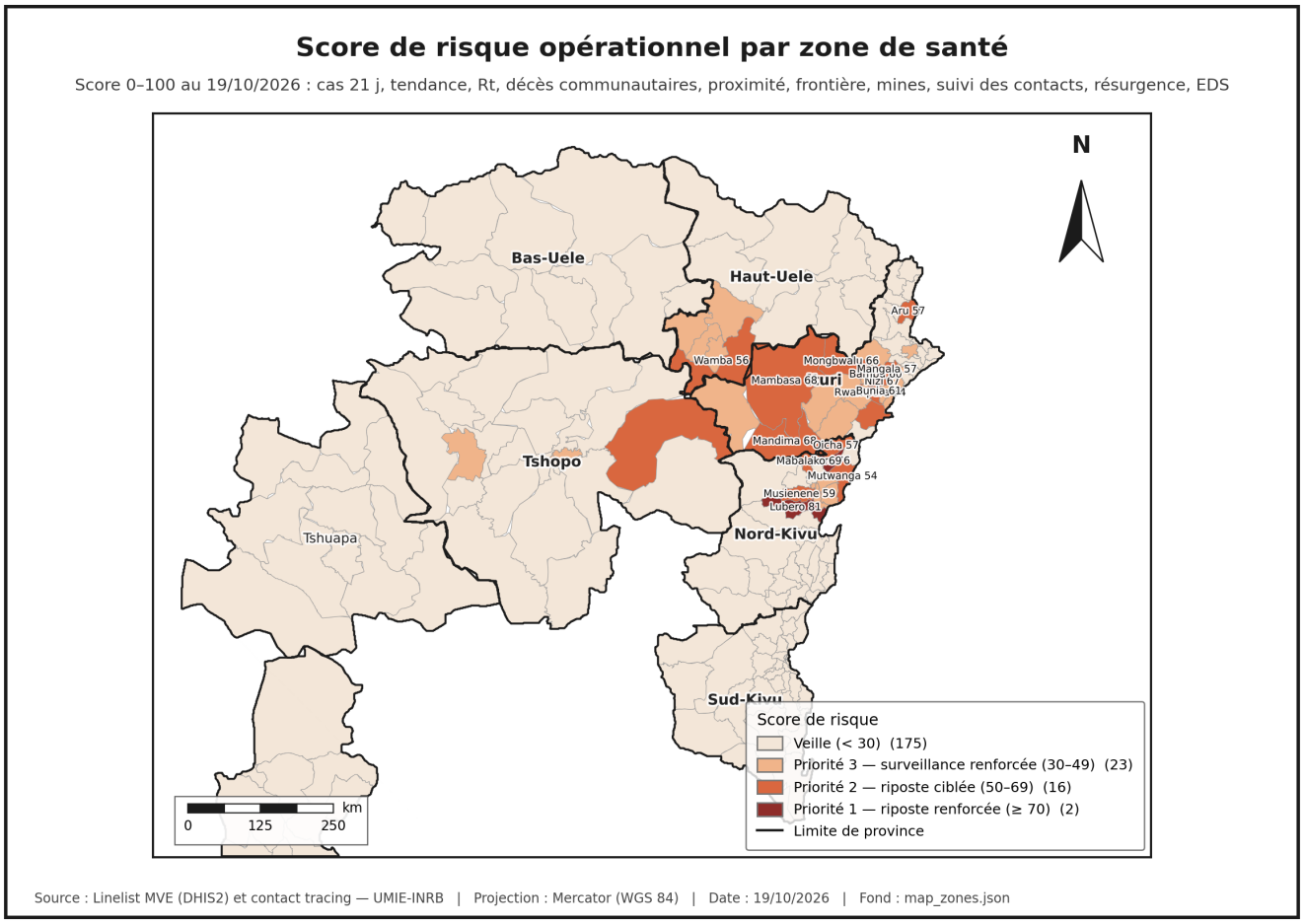



**Figure 9** : score de risque opérationnel par zone de santé (zones de priorité 1 à 3 étiquetées).

**Tableau 9 : Les 15 zones de santé les plus prioritaires selon le score de risque**

| Rang | Zone de santé | Province | Score | Priorité | Cas 21 j | Principaux facteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubero | Nord Kivu | 81 | Priorité 1 | 14 | tendance à la hausse (12), P(Rt > 1) (11), cas des 21 derniers jours (11) |
| 2 | Beni | Nord Kivu | 76 | Priorité 1 | 148 | cas des 21 derniers jours (20), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 3 | Mabalako | Nord Kivu | 69 | Priorité 2 | 41 | cas des 21 derniers jours (15), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 4 | Mandima | Ituri | 68 | Priorité 2 | 145 | cas des 21 derniers jours (20), P(Rt > 1) (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 5 | Mambasa | Ituri | 68 | Priorité 2 | 35 | cas des 21 derniers jours (14), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 6 | Nizi | Ituri | 67 | Priorité 2 | 91 | cas des 21 derniers jours (18), P(Rt > 1) (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 7 | Mongbwalu | Ituri | 66 | Priorité 2 | 18 | tendance à la hausse (12), cas des 21 derniers jours (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 8 | Rwampara | Ituri | 64 | Priorité 2 | 102 | cas des 21 derniers jours (19), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 9 | Bunia | Ituri | 61 | Priorité 2 | 147 | cas des 21 derniers jours (20), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8) |
| 10 | Bambu | Ituri | 60 | Priorité 2 | 29 | cas des 21 derniers jours (14), tendance à la hausse (12), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 11 | Musienene | Nord Kivu | 59 | Priorité 2 | 33 | cas des 21 derniers jours (14), P(Rt > 1) (11), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 12 | Mangala | Ituri | 57 | Priorité 2 | 53 | cas des 21 derniers jours (16), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8) |
| 13 | Aru | Ituri | 57 | Priorité 2 | 8 | tendance à la hausse (12), P(Rt > 1) (11), cas des 21 derniers jours (9) |
| 14 | Oicha | Nord Kivu | 57 | Priorité 2 | 34 | cas des 21 derniers jours (14), P(Rt > 1) (11), proximité d'une zone à incidence élevée (10) |
| 15 | Wamba | Haut Uele | 56 | Priorité 2 | 34 | cas des 21 derniers jours (14), proximité d'une zone à incidence élevée (10), décès communautaires positifs (8) |

## 4. SUIVI DE LA PERFORMANCE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA RIPOSTE

**Tableau 10 : Indicateurs de performance de la surveillance et de la riposte (national)**

| Indicateur | Dernière semaine | Moyenne 4 semaines | Cumul / global | Cible | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouveaux cas confirmés connus comme contacts | 1,2 % | 2,1 % | 0,9 % | ≥ 80 % | Non atteinte |
| Nouveaux cas avec source identifiée | 7,4 % | 8,8 % | 5,8 % | ≥ 80 % | Non atteinte |
| Délai médian début des symptômes → notification | 5,0 j | 5,2 j | 5,0 j | ≤ 3 j | Non atteinte |
| Délai médian début des symptômes → isolement | 5,0 j | 5,0 j | 4,0 j | ≤ 3 j | Non atteinte |
| Contacts vus au cours des dernières 24 h | 31,9 % | 36,2 % | 35,7 % | ≥ 90 % | Non atteinte |
| Alertes investiguées en ≤ 24 h | 99,7 % | 98,9 % | 98,2 % | ≥ 80 % | Atteinte |
| Décès communautaires prélevés (alertes décès) | — | — | 69,1 % | ≥ 80 % | Non atteinte |
| Délai médian prélèvement → résultat | 0,0 j | 0,2 j | 0,0 j | ≤ 1 j | Atteinte |

Cibles de référence modifiables dans config/parametres.json (clé « cibles_rapport »). Dernière semaine = dernière semaine épidémiologique complète (contacts vus : moyenne des 7 derniers jours).

6 indicateur(s) sur 8 n'atteignent pas la cible : nouveaux cas confirmés connus comme contacts; nouveaux cas avec source identifiée; délai médian début des symptômes → notification; délai médian début des symptômes → isolement; contacts vus au cours des dernières 24 h; décès communautaires prélevés (alertes décès).

Qualité des données : score global de conformité de 92,1 % sur 40 contrôles (complétude, cohérence, validité, unicité, actualité) ; le détail figure dans le menu « Qualité des données » du tableau de bord.

## 5. DÉFIS ET LACUNES

- **Transmission non détectée** : seuls 0,9 % des nouveaux cas étaient connus comme contacts et 5,8 % ont une source identifiée ; la majorité des chaînes échappe au listage.
- **Suivi des contacts insuffisant** : 35,3 % des contacts vus lors de la dernière journée (cible ≥ 90 %), 871 contacts non vus depuis plus de 3 jours.
- **Documentation des enterrements** : l'organisateur des funérailles n'est renseigné que pour 4,1 % des décès de la Linelist ; 187 enterrements non sécurisés documentés.
- **Isolement** : 6 732 cas confirmés sans admission enregistrée en CTE (72,3 %) — non-isolement réel ou admission non saisie, à vérifier par province.
- **Concordance SitRep – Linelist** : 8 914 cas au SitRep contre 9 313 dans la Linelist ; 56 zones présentent un écart.
- **Dénominateurs de population** absents : les taux d'incidence et d'attaque par zone ne peuvent pas être calculés (ajouter un fichier de population par zone de santé).

## 6. RECOMMANDATIONS ET ACTIONS PRIORITAIRES

- **Zones de priorité 1** (Lubero, Beni) : riposte renforcée — équipes d'intervention rapide, recherche active des cas, listage exhaustif et suivi quotidien des contacts, prélèvement et EDS de tous les décès communautaires.
- **Zones de priorité 2** (Mabalako, Mandima, Mambasa, Nizi, Mongbwalu, Rwampara, Bunia, Bambu, Musienene, Mangala…) : riposte ciblée sur les aires de santé actives et surveillance renforcée aux limites avec les zones à forte incidence.
- **Retrouver les 871 contacts non vus depuis plus de 3 jours** (listes nominatives par aire de santé dans outputs/confidentiel) et renforcer la supervision des relais communautaires.
- **Investigation rétrograde systématique** de chaque nouveau cas sans lien connu (recherche de la source dans les 21 jours précédant les symptômes, funérailles et structures de soins fréquentées).
- **Prélèvement de tous les décès communautaires** et documentation systématique de l'organisateur des funérailles dans la Linelist.

- **Réconcilier le SitRep et la Linelist** chaque semaine par zone de santé (tableau de concordance du tableau de bord).

### Messages clés à retenir

• Du 13 oct. au 19 oct. 2026, **363 cas confirmés** et 137 décès ont été notifiés (létalité 37,7 %), contre 458 cas la semaine précédente : tendance **en baisse** (-21 %).
• Suivi des contacts : 1 623 contacts en suivi, **35,3 % vus** le 19 oct. 2026, 871 non vus depuis plus de 3 jours ; seuls **0,9 %** des nouveaux cas étaient connus comme contacts.
• 2 zones en priorité 1 (score ≥ 70) et 16 en priorité 2 (50–69) ; zones les plus prioritaires : Lubero (81), Beni (76), Mabalako (69), Mandima (68), Mambasa (68).

## ANNEXE 1 — DÉFINITIONS DE CAS

**Cas suspect** : toute personne, vivante ou décédée, présentant une fièvre d'apparition brutale et ayant été en contact avec un cas suspect, probable ou confirmé, ou avec un animal mort ou malade ; ou toute personne présentant une fièvre et au moins trois des signes suivants : céphalées, vomissements, anorexie, diarrhée, fatigue intense, douleurs abdominales, douleurs musculaires ou articulaires, difficultés à avaler, difficultés à respirer, hoquet ; ou toute personne présentant des saignements inexpliqués ; ou tout décès inexpliqué.

**Cas probable** : tout cas suspect évalué par un clinicien, ou tout décès suspect ayant un lien épidémiologique avec un cas confirmé, sans prélèvement possible.

**Cas confirmé** : tout cas suspect ou probable dont un échantillon est positif au laboratoire (RT-PCR) pour le virus Ebola.

**Contact** : toute personne ayant été exposée à un cas (contact physique, liquides biologiques, même foyer, soins, funérailles) au cours des 21 jours précédant l'apparition de ses symptômes ; suivie quotidiennement pendant 21 jours après la dernière exposition.

**Non-cas** : cas suspect dont les résultats de laboratoire sont négatifs.

Définitions adaptées des définitions standard de l'OMS ; se référer au protocole national en vigueur.

## ANNEXE 2 — MÉTHODES (RÉSUMÉ)

- Période de rapportage : 7 derniers jours glissants jusqu'à la date des données ; semaines épidémiologiques ISO (lundi–dimanche) pour les tendances.
- Rt : modèle de renouvellement (Cori et al. 2013) sur l'incidence par date de début corrigée des retards de notification ; intervalle sériel estimé sur les paires infecteur–infecté des chaînes reconstituées ; comparaison de 9 méthodes dans le tableau de bord.
- Catégories de zones : grille de la riposte (rouge / orange / jaune / vert / non touchée) ; score de risque 0–100 pondéré (voir méthodologie détaillée).
- Létalité : décès / cas confirmés (cumul) ; la létalité de la période récente est sous-estimée tant que l'issue des cas récents n'est pas connue.
- Méthodologie complète avec formules : document « Méthodologie détaillée » fourni avec l'outil.